

15주차

성전파성 감염은 한의학에서 적극적으로 볼 질환이 아니며, 교수님께서 맡으신 부분은 14주차까지의 내용이라고 말씀하심. 성전파성감염은 상식선에서만 알아두라고 하심.

3장 성전파성 감염 STI p.336

1. 개요

★ (클라미디아 감염증)과 (임질)은 여성의 70%까지 전혀 증상이 없을 수 있다. (클라미디아 감염증) 치료하지 않은 여성의 10~40%가 PID로 발전하며, 감염 후 (난관 손상)은 여성 불임의 30~40% 차지한다. (임질)은 남녀 모두에게 불임의 원인이 된다. (클라미디아 감염증)은 신생아 안염을 초래한다. '미상

1) 용어

WHO는 성병을 성전파성감염으로 변경 (1991)

2) 감염로

주로 사람과 사람 사이에 성 접촉으로 전파되나 HIV와 매독은 임신과 출산 중 엄마에서 아기로 전파될 수 있고 혈액제제와 조직 이동을 통해서도 전파가 가능

3) 감염병

- 2020년 1월 최근 감염병 범주 변함 → 1-4급으로 나뉨 (순위도 변경)

제 1 급	생물 테러 감염병, 치명률 높거나 집단감염 위험을 높음 / 음압격리 → 지역사회 전파 시 큰 위험 (SARS, MERS, 코로나 19)
제 2 급	24시간 이내 신고 및 격리
제 3 급	발생추이를 감시할 필요가 있는 감염병 발생하거나 유행시 24시간 이내 신고 (렙토스피라, 쯔쯔가무시, 패혈증, HIV)
제 4 급	1-3급 이외의 유행여부 조사 위해 표본감시 활동이 필요 (신고는 7일 이내) 대부분의 성전파성 감염, 이전의 5군에 있던 회충 등의 기생충 감염 포함

- 과거: 감염병 매개물질, 유행지역 등 감염병의 특성 자체에 초점
- 현재: 감염병의 전파수준에 따른 격리수준, 특히 신고시간 정확히 명시해서 신고의무를 강화시킨 것이 특징적
- HIV는 제 3급 감염병이며, 매독, 임질, 클라미디아 감염증, 연성하감, 성기단순포진, 첨규콘딜로마는 제 4급 감염병

4) [참고/ppt 내용] 역학

- 15-49세에서 치유가능한 성전파성감염(매독, 임질, 클라미디아 감염, 트리코모나스 중)에 매년 4억 4천만명 이상이 새로 감염 (2005.WHO)
- 산모의 임질/클라미디아 감염으로 유발된 신생아 안염으로 매년 1000~4000명의 신생아기 사망
- 2017년 기준, 감염의 발생은 매년 감소 추세. 매독(1기, 2기) 및 성기 단순 포진은 매년 증가. 클라미디아 감염은 감소했다가 다시 증가 추세
- 국내에서는 남성에서의 발생이 더 흔하며, 남녀 모두 25-29세에서 빈발 (성적활동 왕성할 때)
- 여성은 클라미디아 감염증 발생이 가장 많음

5) 병원체에 따른 성 전파성 감염의 종류

세균 Bacterial origin	syphilis(매독), gonorrhea(임질), chancroi(연성하감), non-gonococcal urethritis(비임균성 요도염), chlamydia trachomatis infection(클라미디아), granuloma Inguinale(서혜부육아종), lymphogranuloma venereum(성병림프육아종)
바이러스 viral origin	genital herpes(성기단순포진), condyloma acuminata (콘딜로마), human immunodeficiency virus infection(HIV 감염)
원충과 기생충 protozoan & parasite origin	trichomoniasis(트리코모나스), amoebiasis(이질아메바), scabies(옴), pediculosis pubis(개선,사면발이)

6) 증상 및 합병증

- 일부 성전파성 감염은 증상이 없을 수 있다
- 임질과 클라미디아 감염은 여성의 약 70%까지 전혀 증상이 없을 수 있으나 증상 유무와 관계없이 진행되어 심각한 합병증 유발가능 (무증상 감염, 불임이나 자궁외임신 등의 원인이 될 수 있는 난관손상)
- 성전파성 감염의 일반적인 주요 증후군 : 주로 생식기와 그 주변의 각종 염증성 증상들! 요도 이상 분비물, 성기 궤양, 서혜부 부종 (bubo), 음낭부종, 질분비물, 하복부통증, 신생아 결막염 등 (but 매독 같이 1기~3기에 따라서 전신적 증상을 일으키는 경우도 O)
- 클라미디아 감염증을 치료하지 않은 여성의 10~40%가 PID로 발전하며, 감염 후 난관 손상은 여성 불임의 30~40%를 차지하고 임질은 남녀 모두에서 불임의 원인이 된다
- 임신 초기의 매독은 태아를 감염시킬 수 있으며, 치료하지 않은 경우 사산(25%), 신생아 사망(14%)을 보인다
- 임질은 자연유산, 미숙아, 신생아 안염 초래할 수 있으며, 클라미디아 감염증은 30%에서 신생아 안염을 초래 : 페니실린계 약을 바로 신생아의 안구에 투여

7) 예방

- 가장 확실한 방법은 다른 사람과의 성 접촉을 금하는 것이고 콘돔 사용으로 감염의 95% 이상 예방 가능
- 감염 시 완치될 때까지 성 접촉을 금하고 성 대상자도 검사해서 필요 시 함께 치료
- 한번 치유되었더라도 검진을 통해 조기 발견해서 치료하는 것이 중요
- 일부 ¹HPV에 대한 고위험군에 대한 ²백신이 개발되었으나 그 외의 성 전파성 감염에 대한 예방접종은 아직 없다
 - ① human papilloma virus, 제 4 급, 자궁경부암의 원인
 - ② 서바릭스(2가백신) : HPV 16 번, 18 번에 대한 백신
가다실(4가백신) : 16, 18 번 + 점균콘딜로마를 일으킬 수 있는 6, 11 번에 대한 백신

2. 박테리아성 성 전파성 감염 p.340

1) 매독 syphilis p.340

- 정의: 트레포네마 매독균(treponema pallidum)에 의해서 발생하는 성기 및 전신질환
- 감염 경로 : 1기/2기 매독 환자와 성접촉 시 약 50% 감염, 태아 수직감염, 혈액 감염
- 유래도 깊고 단계에 따라서 심각성도 심하다 / 초기 잡지 못하면 생명까지 위협
- 잠복기는 10-90 일 (평균 3주)
- 증상: 병변은 외음부, 질, 항문, 직장에 나타나나 입술/입에도 나타날 수도 있음

(1) 후천성 매독 by 성접촉, 혈액감염

- 초기매독: 감염된 후 1년 이내 발병 (1기, 2기 매독 / 초기잠복매독)
- 후기매독: 감염된 후 1년 이후 발병 (후기잠복매독 / 3기 매독)

(2) 선천성 매독 by 수직감염

- 초기 선천성 매독: 생후 2년 이내 발병
- 후기 선천성 매독: 생후 2년 이후 발병

(3) 매독의 진단

- 현미경 검사법: 검체에서 암시아 현미경으로 매독균 확인
- 혈청학적 검사법: 위양성 반응이나 병기마다 민감도가 다르므로 해석상에 주의 요망
VDRL(매독선별검사), RPR-CT(치료효과 판정), 특이항체 검사(확진, TPPA&TPHA 활용)
→ 보통 매독선별검사를 우선적으로 시행한 후 다른 검사들을 시행함.
- 요추천자: 후기잠복매독, 신경매독의 의심되거나 다른 3기 매독이 단독으로 나타나는 경우에 시행

(4) 매독의 치료

- 감염된 지 1년 이내: 페니실린 항생제(Benzathine Penicillin)을 1회 근육주사
- 임신 기간에 치료받지 않은 혈청학적 검사 상 양성인 모체로부터 태어난 모든 아이는 페니실린 투여 → 치료는 간단한데 환자들끼리 질환을 숨겨서 문제가 됨.

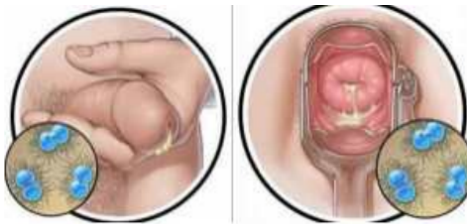
★ 매독의 시기에 따른 피부 병변

1기 매독	- 경성 하감(chancere)이 특징적 → [연성하감과 차이] 연성 하감은 궤양을 이루는 margin 이 흐릿하고 경성 하감은 margin 이 뚜렷함. & 경성 하감은 통증이 없고 연성 하감은 통증이 심함. - 균이 침입한 부위에 10-90 일 후 무통성 경성하감 구진이나 궤양 발생 - 2~6 주 후 자연 소실되나 치료하지 않으면 2기로 진행 - 성 접촉 후 일정 시간 후에 나타나는 외음부 궤양은 치료 시작 전에 반드시 매독을 의심해야 하고 이에 대한 철저한 검사 시행	
2기 매독	- 감염 6주-6개월 후에 발생 - 전신 피부발진과 점막손상이 특징 - 발열 두통 권태감 피부병변(반점, 구진, 농포성 매독진, 편평콘딜로마), 림프절 종대 등 전신증상이 나타나기도 하고 - 치료하지 않은 경우에도 사라질 수 있으나 잠복매독이나 3기로 진행	
3기 매독	- 처음 감염된지 5-20년 후에 발현 - 주 병변은 고무종 gumma (피내, 피하의 경결 - 고무모양의 경결) / 궤양성 궤사를 일으키며 피부와 내장기관, 뼈, 관절을 침범해서 파괴 - 심혈관매독: 상행 대동맥 침범하여 대동맥 폐쇄부전, 대동맥류 야기 - 신경매독: 무증상 매독, 뇌막혈관 매독, 脊髓癱, 진행마비 (심혈관/신경 매독이 진행된 가장 심각한 상태) - 척수로(tabes dosalis): 매독의 척수 침범- 복부, 하지의 전격적인 통증, 마비, 감각 장애 및 동공반응 검사 비정상 - 진행마비: 성격/감정변화 및 치매 등 유발	
잠복매독/ 선천성매독	- 잠복매독: 1, 2기증상이 사라질 때 시작. 증상은 사라지고 감염력은 약해지지만 감염 상태는 지속되어 혈청 검사상 양성 반응 - 선천성 매독: 대개 임신 4개월 후에 감염이 발생, 임신 말기일수록 전염력이 강한 임상기의 매독일수록 잘 전파 - 조기 선천성 매독: 성인의 2기 매독과 비슷한 양상을 보인다 - 후기 선천성 매독: Hutchinson 치아(이빨이 톱니처럼 변함), 간질성 결막염, 군도 정강이 (saber shins 서양칼, xray 사진 참고)	

2) 임질 gonorrhea p.343

- 임균(Neisseria gonorrhoeae)에 의해 감염되어 주로 요도염이나 자궁경부염(내자궁경관 의 선상피에 감염) 등을 일으킴
- 잠복기는 2-7 일 가량이고 여성에서의 무증상 감염의 비율이 높다 (60-80%)
(트리코모나스는 남자에서 무증상, 여성에서 질염 유발)
- 자궁경부염, 요도염에 의한 증상으로 작열감, 빈뇨, 배뇨 시 동통, 질 분비물 증가, 비정상적 월경 출혈, 항문 직장 불편감 등을 호소 → **농뇨가 특징!**
- 임균 감염자의 40% 정도에서 클라미디아 감염증을 동반하기 때문에 임균 감염은 클라미디아 감염증을 나타내는 표지자의 역할
- 임질은 골반염증성 질환(PID)의 원인이 되기도 하고 완전, 불완전 난관 폐색 등으로 불임이나 자궁외임신을 초래할 수 있다
- 출산 시 태아가 질을 통과할 때 감염되어 신생아 안염 등을 유발

진단	- 검체 (요도 또는 자궁경부) 채취하여 직접도말 및 현미경 검사 실시 - 정확한 진단을 위해 검체에서 배양으로 <u>균 분리 동정(PCR)</u> 하거나 검체에서 항원 또는 유전자 검출 DNA 증폭 및 염기서열 확인
치료	- Ceftriaxone, Erythromycin, Doxycycline 등
관리	- 치료 후 배양검사 상 음성일 때까지 성 접촉금지 - <u>상대 접촉자도 같이 치료</u> - 급성 난관염 환자는 발병 60 일 이내 성접촉자 파악해 검사 및 치료



✓슈퍼임질: 임질균이 항생제에 내성이 생긴 경우로, 최근 계속 확산되고 있어 문제

3) 클라미디아 감염증 Chlamydia p.345

- 클라미디아 트라코마티스균(Chlamydia trachomatis)에 의한 요도염이나 자궁경부염 등의 성기부위 질환
- 성 접촉으로 전파, 10 대/어린 여성의 경우 자궁경부 미성숙으로 감염 위험성이 크다
→ 증상은 없지만 다른 STI의 표지자 역할을 하므로 클라미디아가 있으면 모든 STI 검사를 시행해야 함.

증상	- 없거나 경미. 감염 여성의 3/4 에서 무증상 (전파성에 있어서 굉장히 까다로운 병 / 무증상성 PID 유발할 수 있음) - 감염부위가 나팔관으로 퍼지면 복통 요통 오심 발열 성교통 비정상적 출혈 등이 발생 - 치료하지 않으면 약 40%에서 나팔관 감염증 및 골반염증성질환 유발
진단	(진단과 치료는 임질과 유사) - 검체(요도 또는 자궁경부도말)의 세포배양에서 <u>원인균 분리동정</u> , 검체에서 유전자 검출
치료	- 약물: Azithromycin, Amoxicillin 및 Doxycycline 등
관리	- 치료 받지 않은 감염된 어머니로부터 출생한 신생아의 경우 클라미디아 폐렴을 확인하기 위해 생후 3 주, 12-18 주에 흉부 X 선 검사 및 <u>신생아 안염</u> 에 대한 검사 필요 → <u>신생아 안염의 주요한 원인이며 신생아 폐렴과도 관련됨.</u> - 상대 성접촉자도 파악해 검사해야 함



4) 연성하감 Chancroid p.347

- haemophilus ducreyi 균 감염에 의한 성기나 회음부의 통증 및 궤양성 질환
cf. 매독 경성하감과 구분 (연성하감은 통증O, 경성하감은 무통)
- 잠복기 1-35 일이나 통상 4-10 일



성기궤양	- 붉은 구진에서 농포로 진행한 후 통증성 궤양을 형성 - 음순, 질입구, 항문주위 등에 분포 (주로 성기 주변에만 분포)
서혜부 림프절 염 (드름)	- 남성 환자의 1/3. 여성 환자는 보다 낮은 빈도 - 침범된 림프절이 액화 과정을 거쳐 부보(buboes, 임파선종)로 진행되고 저절로 터져서 농을 배출 - 성기 궤양이 나타난 1-2 주 후 발생

5) 서혜부 육아종 Granuloma Inguinale p.348

- 육아종 피막성 구균에 감염된 사람과의 성관계 또는 균이 묻은 손/음식을 통해 전염
- 1주-3개월 사이에 생식기 점막 상에 구진이 융기
- 접촉 시 쉽게 출혈. 궤양으로 발전해 괴사됨
- 진행되면서 궤양은 주변으로 확산되어 표면상으로 점막의 큰 부분을 차지함
- 서혜부 림프절 종창은 드문 편. 치료를 하지 않고 진행되면 뼈나 내부장기에도 침범

6) 성병림프 육아종 Lymphogranuloma venereum p.348

- Chlamydia Trachomatis 균에 의해 감염되어 주로 회음부와 요도입구를 침범
- 잠복기는 1-4 주
- 생식기 점막의 무통성 구진 / 작은 1차 병변 또는 구진, 궤양화하고 감염 2 주후부터 국소 림프절이 종창됨. (주로 일측성)
- 서혜부 대퇴부 림프절 침범 시 서혜부 인대에 의해 분리되는 Groove sign이 특징적
- 다른 클라미디아 감염증에 비해서 치료기간이 3 주 정도로 긴 편
- 제대로 치료하지 않으면 발열 전신쇠약 관절통 결막염 등이 동반되고, 1/3 에서 농양이 형성되고 파열하여 외음부에 누공이 생기고 직장과 요도 협착을 초래함.
- 성기주변에 여러 합병증 유발가능



7) 비임균성 요도염 Non-gonococcal urethritis p.349

- 임균 이외 병원성 미생물 감염에 의한 (주로 chlamydia trachomatis 에 의한)
- 해부학적 구조상 남성에게서 더 많고 (요도길이가 더 기니까) 잠복기 2-3 주
- 배뇨곤란(빈뇨, 배뇨통), 점액농성 요도분비물, 요도불쾌감, 요도소양증 나타나나 여성에서는 이환되었어도 무증상이 많음
- 여성의 경우 점액성 경부 분비물이 생식기로 확산되어 난관 감염, 자궁내막염, 급성 출혈성 방광염, 요도 협착이 생길 수 있다 (PID, 방광염, 요도염을 유발할수도 있음)
- 임신부 감염 시 신생아에게 봉입체성 결막염이나 폐렴이 발생할 위험이 있음
- 마찬가지로 신생아안염, 신생아 폐렴 유발가능
- 비임균성요도염은 '비'임균성이라는 말 때문에 성병이 아니라고 오인하기도 하는데 성병에 해당됨.

3. 바이러스성 성 전파성 감염 p.350

1) 성기단순포진 Genital herpes p.350

- herpes simplex virus type 1,2에 의해 감염
주로 HSV-2에 의해 발생, HSV-1은 입과 입술의 궤양 유발하며 증상이 훨씬 맹렬함
- 무증상 혹은 2-4주 후 자연 치유되는 성기 부위의 수포, 궤양
- 1회 감염으로도 초기 감염 후 바이러스가 신경절에 잠복하며, 면역력이 떨어지면 나타나 등 평생 나타남 (항체가 소용없음)
- 환자는 성 접촉을 금지하고 또한 신생아, 습진 또는 화상을 입은 소아, 면역저하자는 특히 접촉을 금한다. (성전파 바이러스는 건조한 곳에서는 잘 활성화되지 않음.)

2) 첨규 콘딜로마 Condyloma acuminata p.351

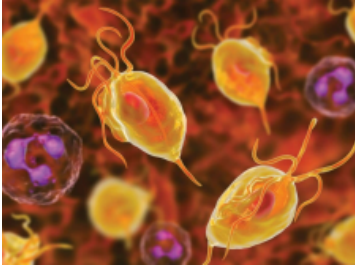
- HPV(인유두종 바이러스) 중 주로 6번, 11번 바이러스 감염에 의해 외음부에 생기는 사마귀성 질환
- 성교 시 직접 침범 받는 곳에 주로 발생, 외음부의 뒤쪽 및 음순에 호발
- 육안으로 확인 가능한 융기된 병변이 특징적, 시간 경과에 따라 구진이 모여서 일정 모양을 이루기도 한다
- 발열, 전신쇠약, 관절통, 결막염 등이 동반
- 1/3에서 농양형성, 파열해서 외음부에 누공이 생기고 직장과 요도 협착 초래

3) 인간 면역결핍 바이러스(HIV) 감염 p.352

- 인간면역결핍 바이러스(HIV)가 주로 CD4+T 림프구를 침범해서 세포성 면역장애를 유발하며 대식세포, 중추신경계 세포, 태반 침범도 가능함
- 잠복기: 5일-3개월 (평균 2-4주)
- 감염 환자의 혈액 직접 접촉, 성접촉, 임신 중 태반을 통해 태아에게, 출산 직후 신생아에게 전파(수직감염)되고 매독, 음부포진, 연성하감 등이 존재 시 전파가 쉬움
- 비특이적 증상으로 열성 인두염이 흔하고, 고열 발한 기력저하 관절통 근육통 두통 림프선 병증이 2주간 지속됨 (처음엔 감기와 유사하다가 보통 폐렴으로 사망함)
- 면역결핍은 일반적으로 10년 후에 뚜렷해지며, AIDS 환자로 발전하면 원충, 바이러스, 세균, 진균 등의 기회감염과 용혈성 빈혈, 혈소판감소증 및 임파선종 등의 면역 및 혈액학적 이상, 신경계 손상과 더불어 비전형적 종양과 세포성 면역 결핍과 관련된 증상이 발현됨 → 항레트로바이러스 카테일 요법으로 평생 관리

4. 원충 및 기생충 성 전파성 감염 p.354

1) 트리코모나스증 Trichomoniasis p.354



- 4 개의 편모를 가지는 짙신모양의 원충인 질 편모충에 의한 감염
- 주로 성교를 통해 전파되고 질염이나 요도염을 유발
- 남성은 대부분 무증상 / 요도나 전립선에 균을 보유하기 때문에 진단과 치료 용이하지 않아 지속적으로 여성에게 재감염 일으키기 쉬움
- 여성은 주로 외자궁경부나 질 요도 skene 선 침범 (생리 직후 많은 양의 거품 있는 썩은 생선 냄새의 질 분비물, 소양감, 국소적 동통, 배뇨통, 성교통 유발)
- 질분비물의 산도는 보통 5.0 이상 (백혈구가 증가, 세균성질증과 공존할 수 있어 clue 세포가 나타날 수 있다) / Whiff test (+)

2) (이질) 아메바증 Amoebiasis p.355

- 기생충인 이질 아메바의 감염으로 야기 → 구강 및 항문성교로 인하거나 낭(cyst)을 포함한 오염된 물, 음식의 섭취로도 발생하는 2 차성 성병
- 남성 동성애자에 있어 대부분이 무증상이나 E. histolytica 는 맹장이나 S 상결장을 흔히 침범해서 혈행이나 림프계를 통해 전파되고 간농양의 합병증을 일으키기도 함
- 장관 침범 시 심한 출혈성 이질, 복통, 탈수 등이 일어남

3) 옴 scabies p.355

- 개선이라고도 하며, 옴진드기(sarcoptes scabiei)라는 피부기생충에 의해 발생
- 잠복기는 4-6 주이며 대체로 안면을 제외한 신체의 전 부분을 침범
→ 옴은 안면부(상부)는 침범하지 않음
- 특징적으로 밤에 심해지는 소양증과 수도(Burrow)라고 하는 2-4mm 의 짧고 불규칙한 터널이 관찰되는 신체적 증후 발현
- 1% Lindane 로션을 전신도포한 뒤 햇볕 노출하고 세척



4) 사면발이 Pediculosis pubis p.356

- 음모슬증이라고도 하고 Pediculosis phthirus ubis 에 의한 기생충 감염
- 주로 음모에 기생하고 음부나 서혜부에 심한 소양증을 일으키며, 이로 인한 찰상이나 이차적 세균감염이 동반
- 음모 외 털이 있는 모든 부위 침범하기도 함

※ 성 전파성 감염과 HIV

임질/매독에 감염되면 HIV 의 기회감염 + 병 자체가 HIV 를 더 쉽게 감염되게 만들
→ 밑줄친 문장만 말씀하시고 아래 표 언급하지 않으심. (피피티에 있어서 참고용으로 넣음)

1) 매독	매독에 감염된 사람미 HIV 에 노출 시 감염될 가능성은 그렇지 않은 경우에 비해 2-5 배 더 높음
2) 임질	임질 환자는 HIV 에 노출되기 쉽고 임질에 걸린 감염인은 그렇지 않은 사람보다 더 쉽게 HIV 를 전파함
3) 클라미디아 감염증	HIV 에 노출될 경우 비감염자에 비해 HIV 감염 가능성이 5 배 정도 더 높음
4) 성기단순포진	HIV 감염에 쉽게 걸리게 하고 HIV 감염된 사람을 더 전염성 있게 만들 수 있음

※ 임신부 감염시 태아 및 신생아에게 미치는 영향

1) 매독	- 매독균은 임신 중 쉽게 태반 통과해 태아를 감염 - 치료받지 않은 아기는 발육지연, 발작, 사망으로 진행
2) 임질	- 출산 시 태아가 질을 통과할 때 전염될 수 있다 - 신생아 실명, 관절염과 생명에 위협적인 혈액 감염의 원인이 될 수 있음
3) 클라미디아 감염증	- 감염된 산모는 미숙아 출산/신생아 폐렴, 결막염 유발 가능
4) 성기단순포진	- 임신 말기의 감염은 태아 감염의 위험이 크고, 분만 시 활 동성 성기 단순포진 감염상태라면 제왕절개 실시

※ 성전파성 감염과 모유수유

“모유수유 가능은 하지만 굳이 할 필요 없다” → 아래표 언급 X

1) 매독	- 아기와 환부가 접촉되지 않는 상황에서 수유가능
2) 임질	- 모유 수유 지속 가능
3) 클라미디아	- 모유수유를 통해 전염되지 않고 치료약도 모유수유에 적절
4) 성기단순포진	- 4 주미만인 아기가 감염될 경우 때로 치명적 - 신생아가 성기단순포진에 접촉되지 않는다면 모유수유 가능
5) HIV	- 모유수유 통해 전파되는 위험율은 다양한 요인에 따라 5-20% - 완전 모유수유를 3개월 이상 한 아기들이 전혀 모유수유를 하지 않은 아기들보다 6 개월 간 HIV 전파에 대한 초과적인 위험은 없다

※ 한의학적 치료

- 1) 매독 (=楊梅瘡) ★ → 양방적으로는 페니실린의 발견이 가장 큰 역할을 함.
- <의학입분> 성교에 따른 감염과 각 장부에 따른 증상 언급
- <외과정종> 기화염독(氣化染毒) 정화염독(精化染毒)
① 기화 : 비폐 장부에 영향을 미친 매독성 피부질환을 의미 (매독 1,2 기)
② 정화 : 간신 장부에 영향을 미친 근골격계 질환과 신경계 질환을 의미 (매독 3 기)

2) 임질, 비임균성 요도염 : 임증, 임탁, 뇨탁, 대하의 범주

- 임증의 8 가지 종류 (팔림 : 기 혈 열 냉 노 석 고 사) 중 노림과 고림이 현대의학에서 말하는 임질과 유사

+ 문헌의 표현

- 수구감(袖口瘡): 연성하감
- 오목(疣目): 첨규 콘딜로마 (성기에 생기는 사마귀)
- 개창(疥癬): 옴을 의미